

Référentiel de formation



Référentiel de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence pour les ambulanciers SMUR

Société Française de Médecine d'Urgence

en collaboration avec

Association Française des Ambulanciers SMUR et Hospitaliers

Association Nationale des CESU



Auteurs :

- Mr Baranger Mathieu - Ambulancier SAMU 87 (AFASH)
- Mr Baudelot Luc - Cadre de santé SAMU 35 (ANCESU)
- Dr Desanlis Cyril - Médecin urgentiste SAMU 08 (ANCESU)
- Mr Grandin Didier - Référent technique associé (SFMU)
- Mr Magnin Jean-Baptiste - Ambulancier SAMU 29 (SFMU)
- Mr Smet Flavien - Ambulancier SAMU 52 (SFMU)

Ce référentiel de formation a été validé par :

Le conseil d'administration de l'AFASH le 20/11/2025 :

Mr Pereira Antoine (Président), Mr Bisson Olivier, Mr Bourdeau Alain, Mr Baranger Mathieu.

Le conseil d'administration de l'ANCESU le 22/11/2025 :

Dr Gheno Gaël (Président), Dr Longo Céline.

Le conseil d'administration de la SFMU le 20/01/2026 :

Pr Charpentier Sandrine (Présidente), Pr Savary Dominique, Pr Jabre Patricia, Pr Debaty Guillaume, Pr Chauvin Anthony, Pr Contenti Julie, Pr Bobbia Xavier, Dr Caplette Catherine, Pr Chouihed Tahar, Dr Duchenne Jonathan, Dr Jenvrin Joel, Pr Mimoz Olivier, Mr Termoz-Masson Nicolas.

Contexte

Le référentiel d'activité de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'ambulancier définit les ambulanciers comme des professionnels de santé et du transport sanitaire. De nombreuses compétences concernant le transport sanitaire sont acquises durant l'enseignement des blocs 3 et 4 du diplôme d'État et constituent une base solide.

De plus, pour être affectés en SMUR les ambulanciers doivent avoir bénéficié de la Formation d'Adaptation à l'Emploi (FAE) et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en intervention d'urgence dans un centre de formation agréé. L'annexe 1 de l'arrêté du 17 mai 2023 contient le référentiel de formation relatif à la FAE. En revanche, il n'existe jusqu'alors aucun référentiel de formation relatif à la conduite, les contenus proposés par les différents centres ne sont pas homogènes.

Dans le but d'optimiser la sécurité des patients et de l'ensemble des équipes, il est essentiel de définir un référentiel de formation pour les ambulanciers SMUR.

Référentiel de formation

D'une durée totale de 21 heures, la formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence, mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'État de structure mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière, est organisée conformément aux recommandations du référentiel de formation.

La formation comprend des enseignements théoriques organisés par les centres d'enseignements des soins d'urgence ainsi que des enseignements pratiques organisés par les centres de formations agréés. La formation théorique doit être réalisée avant la formation pratique.

La formation théorique comprend un module dont le contenu et le volume horaire sont décrits dans le référentiel de formation du présent document.

La formation pratique comprend deux modules dont le contenu et le volume horaire sont décrits dans le référentiel de formation du présent document. Le nombre de formateurs doit permettre la réalisation des ateliers pratiques avec 1 formateur pour 3 apprenants au maximum.

Une attestation de formation est délivrée à la fin de chaque formation, par le centre d'enseignement des soins d'urgence pour le module 1 et par le responsable du centre de formation agréé pour les modules 2 et 3.

L'évaluation des compétences acquises par l'apprenant est assurée par le centre d'enseignement des soins d'urgence et par les formateurs à la conduite tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation.

La durée de validité de l'attestation de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence est de cinq ans. La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation de quatorze heures dans un centre de formation agréé. La formation porte sur une actualisation des connaissances théoriques et un perfectionnement à la conduite, par le biais d'ateliers pratiques et de la conduite sur piste. Une attestation de formation est délivrée à la fin de chaque formation par le responsable du centre de formation agréé.

Module	Titre	Durée estimée
1	Apports théoriques	7h
2	Techniques de conduite en ateliers pratiques	7h
3	Conduite approfondie sur piste	7h

Intitulé du module	Objectifs	Compétences	Contenus	Recommandations pédagogiques	Modalités d'évaluation	Critères d'évaluation
Module 1 Apports théoriques	Développer une compréhension approfondie des principes fondamentaux de sécurité routière, de conduite responsable, sécurisante et de réglementation spécifique des SMUR	1- Connaître la législation en vigueur 2- Prendre conscience du risque routier et connaître les notions de dynamique du véhicule 3- Prendre en compte le véhicule	- Législation VIGP - Droits et devoirs, responsabilité de l'ambulancier SMUR - Usage des avertisseurs sonores et lumineux - Couleur et signalétique des véhicules SMUR - Accidentologie, gestion du stress, étude de cas, jurisprudence - Rédaction de constat amiable - Limitations de vitesse - Facteurs défavorables (Vitesse, fatigue, hygiène de vie, comportements à risque, absence de formation) - Perception, temps de réaction - Connaissances des notions de dynamique du véhicule (centre de gravité, transfert de masse, force centrifuge, énergie cinétique, adhérence, temps de réaction, distance de freinage, distance d'arrêt) - Dispositifs d'aide à la conduite du véhicule (ABS, ESP, AFU, ESR, DSC) - Placement sur la chaussée en agglomération et hors agglomération - Principes et règles de stationnement - Conduite préventive - Impact de la conduite sur le patient et le personnel embarqué - Conséquences si personnel non ceinturés et matériels non arrimés - Prise en compte du véhicule SMUR et remorques (État, entretien général et vérifications diverses) - Sanglage, répartition des poids et arrimage du matériel - Installation au poste de conduite	Les apports de connaissances sont reliés aux activités dans la pratique professionnelle, centrés sur le rôle de l'ambulancier SMUR dans ses tâches quotidiennes Étude de cas concrets La prise en compte du véhicule ainsi que l'installation au poste de conduite sont réalisées sur une ambulance de réanimation SMUR mise à disposition Les situations pédagogiques de ce module doivent s'articuler avec les autres modules	Évaluation des compétences par questionnaire et mise en situation	1- Connaissance du cadre légal 2- Pertinence dans l'identification de situations à risque 3- Conformité de l'application des règles et procédures dans le respect des bonnes pratiques

Module 2 Techniques de conduite en ateliers pratiques	Découvrir et mettre en œuvre les techniques de conduite et d'anticipation dans la gestion des situations d'urgence	1- Mettre en œuvre les dispositifs d'aide à la conduite 2- Réagir face à une situation imprévue et dangereuse 3- Appréhender le gabarit du véhicule 4- Être conscient des effets de la conduite sur le patient et le personnel embarqué	- Utilisation des dispositifs d'aides à la conduite (ABS, ESP, AFU, ESR, DSC) - Tests des distances de sécurité - Freinage d'urgence (Mesure du temps de réaction, distance de freinage et distance d'arrêt) - Évitements - Réaction face à une perte d'adhérence - Mesures d'anticipation - Manœuvre et maîtrise du gabarit - Effets de l'accélération, décélération, freinage et force centrifuge sur le patient et le personnel embarqué	Une synthèse des apports théoriques du module 1 est réalisée en début de module 2 Un travail personnalisé est réalisé sur le comportement, l'attitude et l'analyse de risques routiers Les mesures sont effectuées par un outil de type freinographe, sur piste sèche et humide Les manœuvres sont réalisées sur un parcours balisé avec une ambulance Chaque apprenant doit ressentir les effets de la conduite en se positionnant au moins une fois sur le brancard durant l'atelier dynamique Les situations pédagogiques de ce module doivent s'articuler avec les autres modules	Évaluation des compétences en situation Analyse des résultats chiffrés du freinographe	1- Connaissance des dispositifs d'aide à la conduite 2- Pertinence et conformité des actions mises en place 3- Réussite du parcours 4- Pertinence de l'analyse des effets de la conduite
Module 3 Conduite approfondie sur piste	Développer une maîtrise technique et une compréhension approfondie des gestes essentiels à une conduite efficace et sécuritaire	1- Maîtriser les gestes essentiels à une conduite efficace et sécuritaire 2- Évoluer à allure rapide seul ou en convoi 3- Adapter sa conduite hors intervention	- Placement des mains et des pieds - Gestion du regard, attitude et comportement - Chronologie des gestes - Trajectoires, prise de courbes et virages - Conduite à allure rapide en véhicule léger et ambulance - Réalisation de dépassements - Progression en convoi en véhicule léger et en ambulance - Le retour d'intervention avec et sans patient	La conduite sur piste est effectuée à vitesse réelle et allure rapide Les règles de sécurité seront analysées au regard des situations spécifiques Les situations pédagogiques de ce module doivent s'articuler avec les autres modules	Évaluation des compétences en situation	1- Maîtrise de la conduite efficace et sécuritaire 2- Pertinence et conformité des actions mises en place 3- Adaptation de la conduite

État des lieux des centres de formation existants

Un recensement des formations existantes a été effectué via plusieurs moyens : recherches web, envoi de mails, démarches téléphoniques, réseaux professionnels. Une liste des circuits proposant une formation « adaptée » a pu être établie mais elle reste non exhaustive :

- **ACO CLUB LE MANS** département 72 (1)
- **ACTUA FORMATION** (2)
- **ASPPR FORMATION** (3)
- **CIRCUIT CENTAURE** (4)
- **CIRCUIT BRESSE** département 71 (5)
- **PANACEA 92** département 92 (6)
- **3A FORMATION TEAM PILOTAGE 42** département 42 (7)
- **PASSEPORT PREVENTION CHENEVIERES** département 54 (8)
- **PPAC FORMATION** département 30 (9)
- **TRANSFAIRE PARIS** Circuit du Bourbonnais - Montbeugny département 03 (10)
- **CIRCUIT DE CHARADE** département 63 (11)
- **POZ CONSEILS**

À la suite de ces recherches, nous constatons que de nombreuses formations sont proposées, environ une dizaine. Cependant, il en ressort que les contenus, durées, tarifs, pédagogies appliquées et objectifs diffèrent d'un site à l'autre. Certains centres de formation semblent tout de même s'imposer, proposant un contenu réfléchi et adapté aux compétences que doivent acquérir les ambulanciers SMUR avec des outils et une pédagogie cohérente.

État des lieux de la formation des ambulanciers à travers le monde

Chez nos confrères Européens il n'est pas si évident de trouver des réponses claires du fait des différents fonctionnements tant professionnels (MUG, Paramédics, Ambulanciers techniciens d'urgence, Ambulanciers de transports programmés...) que d'appartenance (Secteur public, État, communes, cantons ... ou du secteur privé) mais quasiment tous les pays proposent des formations durant les cursus de formations initiales. En voici quelques exemples.

Suisse (12) :

Le volume horaire est de 5600 heures de formation soit 3 ans, moins de 1 % de ce volume horaire de formation est destiné à la formation à la conduite. A ce jour, la formation Suisse est assez diversifiée avec des formations dites " feux bleus" composées de rappels des lois et en particulier la Loi « Via Sicura ». Il est surtout inculqué le bon sens et c'est au Procureur que revient le ton à donner aux éventuelles sanctions en cas d'accident. La formation comprend des interviews d'ambulanciers victimes ou auteurs d'accidents de la route via des retours d'expérience (RETEX). Une partie est réalisée sur circuit avec ateliers de pertes d'adhérence, évolution sur chaussée humide, mouillée et gelée, un travail axé sur le regard, le comportement défensif avec l'anticipation comme élément prédominant. Un organisme de formation en Suisse semble se démarquer, il s'agit du TCS (Touring Club Schweiz).

NB : En Suisse, dans le cadre du permis voitures, les jeunes conducteurs doivent effectuer une formation pour gérer les différentes conditions climatiques et cette même formation est refaite par les ambulanciers. Enfin, un travail spécifique est réalisé entre ambulanciers au sein des structures pour évoquer les situations à risques rencontrées, comment elles pourraient être évitées et quelles seraient les mesures à mettre en place à l'avenir.

Belgique (13) :

La Croix-Rouge de Belgique propose un simulateur de conduite pour véhicules d'urgence, permettant aux ambulanciers de s'entraîner dans divers environnements et conditions météorologiques. Ce simulateur offre plus de 5 200 combinaisons différentes pour développer des réflexes de conduite préventive et améliorer la gestion du stress au volant.

Pour les Ambulanciers d'urgence appelés « Ambulanciers 112 », la Peugeot Driving Academy offre une formation spécifique commune SMUR – POLICE sur de vrais véhicules d'interventions, trois niveaux sont proposés :

1. Formation sur 2 jours : Outre les aspects propres aux techniques de conduite et à toutes les manœuvres d'évitement et de contrôle du véhicule, un important chapitre est consacré à la conduite en urgence sur voie publique et à sa législation.
2. Formation sur 3 jours : Spécifiquement développée pour les conducteurs de véhicules d'interventions rapides, au-delà des aspects propres aux techniques de conduite et à toutes les manœuvres d'évitement et de contrôle du véhicule, un important chapitre est consacré à la conduite en urgence sur voie publique et à sa législation (emploi du feu bleu, du bi-tonal, comportement à adopter à l'approche de carrefours, etc.). Deux jours sont destinés aux conducteurs de véhicules d'interventions rapides, incluant les ambulanciers. Le programme couvre la maîtrise du véhicule dans diverses situations, les techniques de conduite en urgence sur voie publique, ainsi que la législation relative à l'utilisation des avertisseurs sonores et lumineux.
3. Recyclage sur 1 jour : Recyclage approfondi, spécifiquement développé pour les conducteurs de véhicules d'interventions rapides, outre les aspects propres aux techniques de conduite et à toutes les manœuvres d'évitement et de contrôle du véhicule, un important chapitre est consacré à la conduite en urgence sur voie publique et à sa législation.

De plus, les ambulanciers exerçant "en transports non-urgents", ce qui est l'équivalent de nos ambulanciers, font uniquement du transport sanitaire et sont reconnus par un arrêté royal. Pour exercer le métier, il est nécessaire de justifier de la réalisation d'une formation dont le contenu est fixé par les autorités avant de réaliser un stage en entreprise. Les ambulanciers doivent valider un examen pour les 4 modules de base dont le 4^{ème} est le transport. Seulement après obtention de cet examen, ils peuvent prétendre à se rendre en stage au sein d'une entreprise (le permis seul ne suffit pas). Pour exercer en SMUR, les permis B et C1 sont obligatoires. Pour utiliser les signaux prioritaires (gyrophares, sirènes) il faut une « *attestation de formation à la conduite en intervention urgente* », formation obligatoire depuis l'arrêté royal du 16 février 1999 ; celle-ci est souvent dispensée par des centres agréés.

Espagne (14) :

La formation à la conduite urgente pour les ambulanciers fait partie d'un ensemble de qualifications professionnelles encadrées par des normes nationales. Cette formation est intégrée dans le cursus de la « ESCUELA SAMU » qui délivre le diplôme de "Técnico en Emergencias Sanitarias" (TES), soit Technicien en Urgences Sanitaires, qui est une formation professionnelle de niveau intermédiaire.

1. Formation "Técnico en Emergencias Sanitarias" (TES):

La durée est d'environ 2 ans, soit 2 000 heures au total, dont une partie en stage en entreprise. La formation inclut des modules spécifiques à la conduite en situation d'urgence telle que la conduite de véhicules sanitaires (Conducción de vehículos de emergencias) et l'assistance sanitaire initiale en situation d'urgence. Le module de conduite de véhicules de secours est axé sur les techniques de conduite d'urgence (conduite défensive, anticipative, rapide mais sécurisée), l'utilisation des gyrophares et avertisseurs sonores dans le respect du Code de la route espagnol ainsi que la sécurité du personnel et des patients lors du transport.

2. Formation complémentaire ou continue :

Après le diplôme TES, les professionnels peuvent suivre des formations spécifiques en conduite d'urgence proposées par les services régionaux de santé (ex. : SEM en Catalogne, SUMMA 112 à Madrid), les organismes privés agréés et les écoles de conduite spécialisées. Ces formations sont souvent pratiques et comprennent des entraînements sur circuit fermé (piste, 4x4...) ou en conditions simulées d'urgence.

Royaume-Uni (15) :

La formation à la conduite urgente destinée aux ambulanciers est rigoureusement encadrée et fait partie intégrante du parcours des "Paramedics" ou "Ambulance support staff". Cette formation est obligatoire pour tout personnel amené à conduire un véhicule d'urgence avec feux bleus et sirènes.

1. Formation à la conduite en urgence "Blue Light Driving" :

Elle permet aux personnels ambulanciers de conduire en toute sécurité à grande vitesse, tout en respectant les exemptions légales du Code de la route britannique accordées aux services d'urgence. C'est une formation complète en 3 étapes avec délivrance d'un certificat en fin de formation.

- Emergency Response Driving → Compétence globale de conduite d'urgence.
- Blue Light Training → Type spécifique d'Emergency Response Driving, qui autorise l'usage des feux bleus et sirènes (blue lights & sirens).
- Emergency Driving Certificate → Certification obtenu après la formation.

La durée est de 3 à 4 semaines à temps plein, selon le niveau initial et l'organisme formateur. La formation contient des techniques avancées de conduite défensive, de la conduite à haute vitesse (high-speed response driving), la prise en compte des risques environnementaux et urbains, de la navigation avec priorité de passage (feux bleus, sirènes) ainsi que l'utilisation de la radio et la coordination avec les autres services d'urgence. Cette formation dispose également d'une partie de conduite en situation simulée de stress (nuit, pluie, trafic, passage d'intersections...), l'évaluation est continue (théorique et pratique).

Pour prétendre à cette formation, il faut être déjà ambulance driver, paramedic trainee, ou emergency care assistant, avoir un permis de conduire britannique complet (full UK driving licence) depuis au moins 1-2 ans et passer un test de sélection (évaluation de conduite de base).

Le recyclage ou « refresher/requalification » dure de 2 à 5 jours, tous les 3 à 5 ans en général. Certains Trusts NHS l'imposent tous les 3 ans, d'autres peuvent aller jusqu'à 5 ans selon l'activité du conducteur et les incidents signalés.

2. Formation des paramedics (niveau universitaire) :

Pour devenir paramedic, il faut suivre un BSc Paramedic Science en université reconnue (ex. : University of Hertfordshire, University of West England, etc.). Durant cette formation, les étudiants passent par des modules de Emergency Driving. Certains NHS Trusts les envoient en formation spécialisée de conduite via des écoles internes (ex. : London Ambulance Service, North West Ambulance Service)

3. Organismes formateurs reconnus :

NHS Ambulance Trusts (ex. : London, West Midlands, South Central...)

Driver Training Units internes à chaque service ambulancier

Private providers agréés comme :

- Blue Lamp Trust
- Emergency Response Driver Training Ltd (ERDT)
- Bluelight Emergency Driving Ltd

Ces organismes forment sur des véhicules équivalents aux véhicules du quotidien et après examen délivrent un certificat reconnu pour la conduite de véhicules prioritaires à valider tous les 5 ans maximum.

Québec (16) :

Il existe un système « Ambulance-école » à plusieurs niveaux.

1. Permis Classe 4A (véhicule d'urgence) :

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) exige un permis classe 5 valide, la réussite d'un examen théorique (30 questions, minimum 22 bonnes réponses) et une formation en conduite préventive de véhicule d'urgence, typiquement 16 h (offerte par des écoles privées ou rattachées aux programmes ambulanciers).

2. Programme collégial (DEC en Soins préhospitaliers d'urgence) :

La durée est de 3 ans, soit environ 2000 heures de cours et 300 à 500 h de stage. Ce programme intègre la conduite d'ambulance en contexte de simulation (plateau pratique) et une formation spécifique aux véhicules d'urgence (prérequis du permis 4A).

3. Formations complémentaires axées sur la conduite préventive :

Proposées via le Réseau des services aux entreprises (ex. FQR). La durée typique est de 4 h à 16 h. Y sont abordés la gestion du stress et les techniques de conduite sécuritaire et écoénergétique en situation d'urgence.

Tableau comparatif :

Pays	Durée formation urgence	Conduite d'urgence incluse	Stage pratique	Maintien compétences	Certification Brevet
Belgique	160 h + 40 h	Partie formation intégrée	Oui	24 h/an et rééval. 5 ans	Brevet AMU
Espagne	~2 ans (2000 h avec TES)	Oui Module dédié	Oui	Non précisé	TES
Royaume-Uni	3–4 semaines + études universitaire (BSc)	Oui Formation Blue Light	Oui (NHS & Trusts)	Formation continue NHS	Emergency Driving Cert. + Paramedic BSc
Suisse	1 à 3 ans (~5600 h pour ES)	Oui (Complet)	Oui (Stages hospitaliers)	Formation continue	Technicien brevet fédéral ou ES
Québec	Classe 4A (SAAQ) minimum	Oui via DEC + cours préventifs	16 h + intégration DEC	DEC (3 ans) + stages	DEC (3 ans) + stages

État des lieux et attentes des ambulanciers SMUR

Afin de construire un référentiel de formation le plus adapté aux besoins, il nous semblait nécessaire de réaliser également un état des lieux de la formation et des attentes des ambulanciers SMUR. Pour cela, un questionnaire a été établi avec Google Forms. Il contient des données démographiques, le niveau de formation (FAE, conduite, formation continue), l'intérêt et l'impact de la formation sur la conduite, les attentes en termes de contenu de formation ainsi que la survenue d'un accident ou incident en SMUR. La diffusion de ce questionnaire à destination des ambulanciers a été faite par mail auprès des cadres de santé, accompagné d'une lettre explicative. Les réponses ont été collectées de Juin à Septembre 2025.

Nous avons obtenu 331 réponses au questionnaire, de 49 départements différents. Les résultats sont détaillés en annexe 1 du présent document. La plupart des répondants ont plus de 10 ans d'ancienneté (47,7%) et sont titulaires de leur poste (86,1%). Bien que réglementairement obligatoire, la FAE n'est effectuée avant la prise de poste que dans 29,9% des cas contre 51,1% après la prise de poste. 14,2% ne sont pas titulaires de la FAE mais en ont fait la demande.

Concernant le stage de sécurité routière et de conduite en intervention d'urgence obligatoire, 44,7% déclarent l'avoir réalisé après la FAE et 40,8% avant. Il est effectué principalement sur 2 jours (84,4%). Selon notre questionnaire, avec 78,7% de répondants ayant réalisé une formation au Mans, le centre de formation de l'Automobile Club de l'Ouest se positionne clairement en tant que leader. D'autres centres de formation se distinguent également, tels que les circuits Centaure (10,1%) et Beltoise (8,8%).

Parmi les 283 répondants ayant bénéficiés d'une formation, 235 (83%) ont trouvés cette formation très utile. Les formations sont principalement réalisées sur des véhicules légers (97,2%) et des ambulances de réanimation (54,8%). Enfin, 248 personnes (87,6%) estiment que la formation a changé leur façon de conduire en intervention. L'objectif du questionnaire était également d'évaluer, à travers les réponses ouvertes des participants, ce que la formation à la conduite d'urgence change concrètement dans la conduite quotidienne des ambulanciers SMUR. L'analyse porte sur plusieurs centaines de réponses, très homogènes dans leurs thématiques, révélant une transformation à la fois technique, comportementale et cognitive.

Le terme anticipation est de loin le plus cité : il apparaît dans la quasi-totalité des réponses (plus de 80%). Les participants soulignent une meilleure capacité à prévoir les situations dangereuses, à lire la route et à analyser le comportement des autres usagers. Les ambulanciers affirment adapter davantage leur vitesse, leurs distances de sécurité et leurs trajectoires. Cette anticipation accrue se traduit par une réduction des prises de risque et une plus grande stabilité dans la conduite d'urgence.

Un deuxième effet fort concerne la maîtrise technique du véhicule et la connaissance de ses limites physiques et électroniques. Les ambulanciers décrivent une amélioration nette de leur capacité à gérer le freinage d'urgence, effectuer des manœuvres d'évitement, comprendre et exploiter les aides électroniques (ABS, ESP, etc.). Cette compréhension permet une conduite plus fine, fluide et efficace, notamment en conditions météorologiques défavorables.

La formation favorise une prise de conscience et un changement d'attitude par le biais d'une réflexion approfondie sur la sécurité : les ambulanciers disent avoir modifié leur rapport à la vitesse et à la notion d'urgence. Ils insistent sur le fait qu'une conduite maîtrisée et anticipée n'entraîne pas de perte de temps, mais augmente la sécurité de l'équipe et des patients. Cette prise de conscience du risque s'accompagne d'une volonté d'autoévaluation permanente et d'un renforcement de la vigilance.

Les aspects ergonomiques ressortent également : les ambulanciers évoquent une meilleure position au volant, un regard plus efficace, une gestion plus précise du volant et des pédales. Ces ajustements contribuent à une conduite plus stable, moins fatigante et donc plus sûre. Par ailleurs, plusieurs réponses soulignent une meilleure attention portée au confort de l'équipage et du patient (conduite plus douce, moins de secousses, meilleure stabilité). Cette notion est essentielle, car le patient et l'équipe médicale doivent avoir confiance en la conduite de l'ambulancier et ne pas se sentir mis en danger.

La formation est perçue comme essentielle et valorisante. Quelques limites sont néanmoins mentionnées : différence entre les véhicules utilisés en stage et les véhicules SMUR réels (gabarit, PTAC, freinage), également le besoin de formations régulières, souvent freinées par un manque de budget. À noter que parmi les 283 répondants ayant effectué la formation, seul un tiers bénéficie d'une formation continue de façon plus ou moins régulière, tandis que 67,1% n'y ont pas accès malgré une demande faite auprès de l'encadrement dans 39,9% de cas.

Nous pouvons alors conclure que la formation à la conduite d'urgence engendre un changement profond de la culture de la conduite des ambulanciers SMUR : Anticipation accrue, maîtrise technique renforcée, réduction des prises de risques, amélioration du confort et de la sécurité collective. Elle développe une véritable intelligence de la route, mêlant connaissance mécanique, observation, gestion du stress et responsabilité partagée. La demande d'un entretien régulier des compétences ressort clairement, traduisant un engagement fort pour une conduite d'urgence sûre, maîtrisée et responsable.

Concernant les ambulanciers n'ayant pas encore bénéficié d'une formation à la conduite d'urgence, ils perçoivent celle-ci comme un levier essentiel d'amélioration de la sécurité et de la maîtrise du véhicule. Parmi les 48 répondants, 47 estiment que la formation pourrait changer leur manière de conduire en intervention. Ils s'attendent à acquérir une meilleure anticipation des risques et des comportements des autres usagers, ainsi qu'à développer des réflexes plus naturels face à des situations critiques (freinage d'urgence, perte d'adhérence, manœuvres d'évitement).

La formation est également imaginée comme un moyen d'approfondir la compréhension technique du véhicule : ses capacités, ses limites et l'usage optimal des aides électroniques (ABS, ESP, etc.). Elle est associée à un gain de sécurité globale, une conduite plus souple, et une réduction du stress pour l'ambulancier comme pour l'équipage.

Les répondants évoquent enfin des attentes autour du placement du véhicule, de la posture de conduite et de la gestion de la vitesse, considérant que la formation pourrait consolider les bases d'une conduite d'urgence plus responsable et mieux maîtrisée.

Globalement, la perception de la formation est largement positive, même chez ceux qui n'en connaissent pas le contenu précis : elle est vue comme une mise à niveau utile, un moyen de corriger les mauvaises habitudes et de renforcer la sécurité collective.

Les éléments jugés importants à aborder durant les formations sont listés dans le tableau suivant.

	N 331	%
Freinage d'urgence	297	89,7
Évitements	287	86,7
Perte d'adhérence	280	84,6
Dynamique du véhicule et transfert de masses	276	83,4
Conduite rapide	256	77,3
Temps de réaction et distances de freinage	247	74,6
Réglementation	192	58
Découverte des dispositifs d'aide à la conduite (ABS, ESP, ASR, AFU)	173	52,3
Conduite d'ambulance avec patient	165	49,8
Conduite préventive	163	49,2

Par ailleurs, nous avons interrogé les ambulanciers sur la survenue éventuelle d'un accident de la circulation en intervention SMUR. Parmi les 331 répondants, 226 (68,3%) n'ont jamais eu d'accident, 102 (30,8%) ont déjà eu un accident modéré ou accrochage matériel (dont 6 n'ayant pas bénéficié de formation), et 3 (0,9%) déclarent avoir été confrontés à un accident grave. Ces 3 ambulanciers sont titulaires depuis plus de 10 ans et ont bénéficié tous les 3 de la formation, mais un seul dispose d'une formation continue tous les 4 à 5 ans. Ces chiffres nous rappellent que malgré l'expérience et les formations, le risque routier sera toujours présent en intervention SMUR. Les ambulanciers doivent en être pleinement conscients.

Enfin, notre questionnaire proposait dans sa dernière partie de transmettre des remarques ou observations. L'analyse de ces réponses ouvertes montre que les ambulanciers interrogés expriment massivement un attachement fort à la formation à la conduite d'urgence, perçue comme un outil essentiel de sécurité, de professionnalisation et de valorisation du métier. Cependant, de nombreux obstacles persistent dans son accès, sa fréquence et son adaptation au terrain.

La principale demande concerne la mise en place de recyclages réguliers et obligatoires afin de maintenir les compétences et d'éviter la dérive des pratiques. Les répondants insistent également sur la nécessité d'une formation systématique dès la prise de poste, considérant que la maîtrise de la conduite en urgence doit être un prérequis à toute affectation SMUR. La législation en vigueur est pourtant claire, comme en témoigne l'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2023 relatif à la FAE. Nous constatons cependant que peu d'établissements respectent ce cadre légal obligatoire.

Plusieurs remarques portent sur la qualité pédagogique des formations actuelles : l'usage de véhicules non représentatifs, le manque de mise en situation réelle ou la faible durée des stages limitent parfois la transférabilité des acquis. Une harmonisation nationale des contenus et des standards de formation est vivement souhaitée. Les contraintes administratives et budgétaires sont perçues comme des freins majeurs.

Enfin, plusieurs intervenants rappellent que la sécurité routière dépend aussi de la conduite des autres usagers, plaidant pour une meilleure sensibilisation du grand public face aux véhicules d'urgence.

Bibliographie et données d'accidentologie

Au-delà des attentes des ambulanciers, il était pour nous indispensable de consulter la littérature existante afin d'identifier scientifiquement les risques de la conduite en intervention d'urgence. Cette analyse doit ainsi mettre en évidence les thématiques essentielles devant être abordées lors des formations délivrées aux ambulanciers de Structure mobile d'urgence et de réanimation (Smur).

Tout d'abord, il semble nécessaire de rappeler l'importance du cadre légal de la conduite en intervention d'urgence. En effet, conduire un véhicule d'intérêt général prioritaire (VIGP) ne signifie en aucun cas avoir tous les droits. Au-delà de l'usage des avertisseurs spéciaux justifié par l'urgence de la mission, l'absence de mise en danger des autres usagers de la route reste un élément capital que doit maîtriser l'ambulancier (17) (18). En cas d'accident, sa responsabilité pénale ou administrative pourrait être retenue si ce cadre légal n'est pas respecté, par négligence ou imprudence avérée principalement (19). Pour exemple, Didier Grandin publiait en 2022 dans la revue *Turbulence* « Un ambulancier condamné pour accident mortel ». Suite à ce drame, le conducteur sera condamné à un an de prison avec sursis et un an de suspension de permis.

Les accidents de véhicules d'urgence et leurs origines devraient être étudiés afin d'en tirer des enseignements pour l'évolution des pratiques. À titre de comparaison, le domaine aéronautique dispose d'un bureau d'enquête et d'analyse (BEA) (20). Son rôle est de réaliser des enquêtes de sécurité sur les accidents ou incidents graves d'aviation civile survenus en France afin d'en établir les circonstances, d'en identifier les causes et les facteurs contributifs. Chaque enquête donne lieu à la publication d'un rapport, assorti le cas échéant de recommandations de sécurité. Les enquêtes du BEA ont pour unique objectif l'amélioration de la sécurité aérienne. Malheureusement, il n'existe à notre connaissance aucun rapport qui recense les accidents des véhicules Smur en France, entraînant un manque de données dans la littérature. Les quelques publications existantes font néanmoins consensus sur l'intérêt d'une réflexion générale sur la conduite en intervention d'urgence.

Battefort et al. ont mené une étude sur les accidents des unités mobiles hospitalières (UMH) des Smur Français sur un an (21). Avec près de 436 000 interventions déclarées dans cette étude, les résultats montrent que le nombre d'accidents concernant une équipe Smur en intervention pourrait paraître peu important en regard du nombre de sorties (1 accident matériel pour 1500 sorties environ). Cependant la gravité des accidents corporels dans le cadre de l'étude (mise en jeu du pronostic vital ou décès pour 20 personnes en un an), la perte de temps pour l'intervention en cours, imposent la nécessité d'une réflexion nationale (vitesse, règles de conduite, cahier des charges concernant la sécurité des véhicules et du matériel embarqué...). À noter également qu'il existait une différence significative du taux d'accident en Smur entre les différents types de conducteur, tout particulièrement entre les ambulanciers et les non professionnels de la conduite (AS, IDE, IADE, médecin). Ce chiffre plaide pour que les équipes Smur bénéficient toutes d'un conducteur professionnel à chaque sortie.

Dans ce contexte, rappelons que la composition de l'équipe Smur est définie dans le code de la santé publique (22), et précise que le conducteur doit être titulaire du diplôme d'État d'ambulancier (23). Pour être affecté en Smur, ce dernier doit également bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi (FAE) et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en intervention d'urgence dans un centre de formation agréé (24) (25). L'encadrement du service doit être garant du respect de ces formations obligatoires avant la prise de fonction des agents.

En 2013, Valli et al. ont quant à eux étudié le niveau de connaissance des ambulanciers de Smur en sécurité routière. Bien qu'elle ne soit pas forcément représentative au vu de la taille du groupe étudié (18 ambulanciers), cette enquête révèle tout de même des manques importants sur la connaissance de la sécurité routière et appelle des mesures correctives. Ils concluent également qu'il conviendrait

de privilégier et réitérer la formation en conduite d'urgence dans le plan de formation des ambulanciers (26).

L'étude de Bui et al. a démontré qu'une formation peut permettre de réduire de manière significative le nombre d'accident (27). De même, une analyse vidéo de différents types de conduite a mis en avant qu'une conduite défensive diminuait le nombre de situation potentiellement dangereuse (28), à l'inverse d'une conduite agressive plus à risque. La vitesse excessive et les freinages brusques sont des comportements associés aux accidents (29). Le stress du départ en intervention provoque une décharge d'adrénaline. Cette décharge peut entraîner une conduite plus agressive et une prise de risque plus importante. Il a été démontré qu'une personne au caractère impulsif et compétitif était associé à une augmentation du risque d'accident, de mauvaises habitudes de conduite, du non-respect du code de la route (30). De même, un excès de confiance chez les conducteurs expérimentés contribue à l'augmentation de prise de risque et de comportement dangereux (31). Il est alors essentiel de rappeler que l'ambulancier doit garder une attitude professionnelle et une maîtrise de soi en permanence.

Au-delà du risque routier que présente ce type de conduite, l'impact sur le patient doit être considéré. Les temps de trajets peuvent être diminués de manière plus ou moins significative en fonction du secteur d'intervention (32) (33) (34). Cependant, en l'absence de bénéfice évident, ces quelques minutes gagnées par rapport au risque accru d'accident interpellent. Dans une étude de Jarvis et al., plus de 85% des interventions étaient réalisées en utilisant les avertisseurs sonores et lumineux, mais moins de 7% étaient des urgences vitales (35). Rappelons également que ce n'est pas le temps total en préhospitalier qui a le plus fort impact sur la mortalité mais principalement le temps passé sur place (36). Les délais d'engagement et de départ des équipes sont aussi à prendre en compte, le proverbe « rien ne sert de courir, il faut partir à point » prend ici tout son sens. Dans tous les cas, le gain de temps ne doit jamais s'envisager sur la route. Une équipe médicale efficace est une équipe qui arrive. Les effets de la conduite sur le patient lors de son transport sont eux aussi à prendre en compte. Les freinages et accélérations modifiant la dynamique des fluides, ces changements de rythmes peuvent avoir un effet sur l'hémodynamique du patient, ou encore générer des mouvements délétères dans le cas d'un traumatisé sévère par exemple (37). Le mal des transports provoqué peut également augmenter le risque de nausées et dégrader la qualité des soins (38). C'est pourquoi la conduite de l'ambulance elle-même doit être considérée comme un élément essentiel des soins.

Un retour d'expérience sur près de 1800 ambulanciers a été mené par Didier Grandin de 2004 à 2024 sur le circuit Jean Pierre Beltoise, lors des stages de conduite en situation d'urgence dans le cadre de la FAE. On note premièrement des imprudences majeures dans les précautions qui doivent être prise lors du franchissement des différents types d'intersections, plus particulièrement en zone urbaine ou péri urbaine. Aussi, un positionnement souvent trop proche de l'arrière du véhicule qui précède entraînant des chocs sur l'avant. Une autre cause d'accident identifiée, en nette progression depuis 2010, est l'accident sans tiers. Les raisons seraient un véhicule souvent trop puissant non maîtrisé, en limite de charge utile autorisée avec des chargements mal équilibrés, ou encore une tenue de route précaire (par exemple les Pick up). Les conditions météorologiques et la vitesse sont là aussi identifiées. Ces éléments mettent en évidence le besoin d'une réflexion sur la conception et les critères de sécurité auquel doit répondre un véhicule d'urgence.

Les accidents impliquant un véhicule de secours sont significativement plus nombreux en conduite d'urgence, lorsque les gyrophares et la sirène sont activés. La majorité de ces accidents se produisent au passage de carrefour et feux de signalisation, dans les changements de direction ou les dépassements (30) (39) (40). Dans une grande majorité des cas, il s'agit d'une collision avec une voiture. Bien que les accidents impliquant une ambulance avec un poids lourd, un piéton ou un deux roues soient de faible proportion, ses conséquences ne peuvent être négligées. Le franchissement d'un feu rouge est un risque majeur. Un système de préemption des feux de signalisations permettant aux

véhicules de secours de rendre l'itinéraire prioritaire, tel qu'utilisé en Suisse par exemple, semble réduire de manière significative le nombre d'accident. Le risque de choc frontal est quant à lui plus présent hors agglomération, en corrélation avec la gravité des blessures engendrées. L'absence de port de la ceinture de sécurité est logiquement liée à un risque de blessures graves ou de décès.

Pour se rendre sur les lieux d'intervention, plusieurs personnes sont présentes à l'avant du véhicule, ce qui permet d'optimiser la vigilance et à l'ambulancier de se concentrer sur la conduite uniquement. Au retour, si l'ambulancier est seul à l'avant, il peut être amené à effectuer d'autres tâches (message radio) induisant une baisse d'attention et détournant le regard de la route. Ces autres tâches peuvent augmenter le temps de réaction de manière significative.

La charge cognitive en conduite d'urgence est importante, l'ambulancier doit analyser en permanence l'environnement, identifier les zones à risque et prendre des décisions rapides en conséquence. Le bruit généré par la sirène peut perturber la réception d'un message radio ou la perception des véhicules environnant. De même, les gyrophares peuvent modifier la perception. Le passage d'une ambulance peut être indirectement source d'accident, lorsque les autres véhicules se déportent sur le côté, franchissent un feu rouge pour laisser passer, ralentissent. Selon Saunders et Gough, plus de 60% des usagers ont dû modifier leur positionnement sur la route pour laisser passer une ambulance. Bien que la plupart parviennent à réaliser une simple manœuvre, un quart estime être en difficulté (41). De plus, certains usagers peuvent paniquer instantanément à l'approche d'un véhicule de secours.

Pour conclure, rappelons que l'ambulancier doit être pleinement conscient des risques liés à la conduite d'un VIGP et connaître le cadre légal dans lequel il évolue. La prévention et l'anticipation des situations à risque est primordiale, la maîtrise de la dynamique du véhicule est pour cela indispensable. Si un danger immédiat se présente malgré tout, l'ambulancier doit être en mesure d'effectuer les manœuvres adaptées, comme par exemple un freinage ou évitement d'urgence.

Les recommandations faites dans ce référentiel de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence tiennent compte des éléments ci-dessus. La formation doit permettre aux ambulanciers d'acquérir des compétences non techniques en abordant toutes les notions théoriques essentielles, et d'acquérir également des compétences techniques par une mise en pratique. Pour cela, trois modules seront enseignés :

- **Apports théoriques**
- **Techniques de conduite en ateliers pratiques**
- **Conduite approfondie sur piste**

Références

1. L'Ouest AC de. [mapreventionaco.fr](https://www.mapreventionaco.fr/formations-samu-smur). [cité 25 nov 2025]. Stages SAMU-SMUR - ACO Formations. Disponible sur: <https://www.mapreventionaco.fr/formations-samu-smur>
2. Actua Formation [Internet]. [cité 25 nov 2025]. Actua Formation : Formation de Conduite pour Professionnels. Disponible sur: <https://www.actua-formation.fr/>
3. ASPPR – ASPPR FORMATION [Internet]. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://aspprformation.fr/>
4. Centaure [Internet]. [cité 25 nov 2025]. Centaure. Disponible sur: <https://www.centaure.com/>
5. Formation securite routiere - Circuit de Bresse [Internet]. 2021 [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://circuitdebresse.com/formation-securite-routiere/>
6. Formation Conduire un véhicule d'urgence : Précision, vitesse et sécurité [Internet]. Panacéa. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://www.panacea-conseil.com/formation/conduire-un-vehicule-durgenceprecision-vitesse-et-securite/>
7. Formation sécurité routière Loire | 3A Formation & Team Pilotage 42 [Internet]. Team pilotage. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://www.teampilotage.fr/formation-securite-routiere-loire/>
8. Formation VÉHICULES PRIORITAIRES [Internet]. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://www.passeport-prevention.fr/formation/vehicules-prioritaires/>
9. Formation à la Conduite Spécifique : Conduite Rapide ou Tout-Terrain [Internet]. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://ppac-formation.fr/securite-routiere/123-formation-conduite-specifique.html>
10. ASSOCIATION TRANSFAIRE - Conduite d'un véhicule d'urgence : formation pratique [Internet]. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://www.transfaire.org/catalogue-de-formations/formation/232/conduite-dun-vehicule-durgence-formation-pratique/>
11. Nos formations sur mesure [Internet]. Charade. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://www.charade.fr/entreprises/formations/>
12. RLP_Rettungssanit%C3%A4t_f_20221031.
13. Save My Life Asbl [Internet]. [cité 25 nov 2025]. Formation d'ambulancier TMS / TNUP. Disponible sur: <https://www.savemylifeasbl.be/formation-d-ambulancier-tms>
14. Curso de Conducción de Ambulancias y Vehículos 4x4 [Internet]. Escuela SAMU. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://escuelasamu.com/catalogo/cursos-especificos/curso-de-conduccion-de-ambulancias-y-vehiculos-4x4/>
15. Ambrose J. Emergency response driving education within UK ambulance services. *Journal of Paramedic Practice*. 10 juin 2013;5(6):351-3.
16. Soins préhospitaliers d'urgence [Internet]. Cégep de l'Outaouais. [cité 25 nov 2025]. Disponible sur: <https://cegepoutaouais.qc.ca/programmes/programmes-techniques/sante-et-services-sociaux/soins-prehospitaliers-urgence/>
17. Article R311-1 - Code de la route - Légifrance [Internet]. [cité 10 févr 2025]. Disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045025478
18. Article R432-1 - Code de la route - Légifrance [Internet]. [cité 10 févr 2025]. Disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006842345
19. Bouriaud A. Responsabilité de l'ambulancier SMUR et sécurité routière. 2008;
20. Accueil - BEA - Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile [Internet]. [cité 10 févr 2025]. Disponible sur: <https://bea.aero/>
21. Battefort F, Ammirati C, Krim F, Vincent G, Barnoin S, Némitz B. ÉTUDE NATIONALE DES ACCIDENTS DES UMH DES SMUR FRANÇAIS SUR UN AN. 7 mars 2008;
22. Article D6124-13 - Code de la santé publique - Légifrance [Internet]. [cité 9 févr 2025]. Disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048840189
23. Article R6312-7 - Code de la santé publique - Légifrance [Internet]. [cité 9 févr 2025]. Disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032618795
24. Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière - Légifrance [Internet]. [cité 10 févr 2025]. Disponible sur: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046807273>
25. Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'Etat de structure mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière.
26. Valli D, Maupin T, Delgado D, Gheno G, Savary D. Quel est le niveau de connaissance des ambulanciers de SMUR en sécurité routière ? SFMU. 2013;

27. Bui DP, Balland S, Giblin C, Jung AM, Kramer S, Peng A, et al. Interventions and controls to prevent emergency service vehicle incidents: A mixed methods review. *Accident Analysis & Prevention* [Internet]. 1 juin 2018 [cité 16 nov 2024];115:189-201. Disponible sur: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000145751830006X>
28. Prohn MJ, Herbig B. Potentially Critical Driving Situations During “Blue-light” Driving: A Video Analysis. *West J Emerg Med* [Internet]. mars 2023 [cité 4 févr 2024];24(2):348-58. Disponible sur: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10047724/>
29. Bui DP, Hu C, Jung AM, Pollack Porter KM, Griffin SC, French DD, et al. Driving behaviors associated with emergency service vehicle crashes in the U.S. fire service. *Traffic Injury Prevention* [Internet]. 17 nov 2018 [cité 14 août 2024];19(8):849-55. Disponible sur: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2018.1508837>
30. Chew KS. Types and risk factors of ambulance accidents: A scoping review. 2022;77(1).
31. H H, J C, P S. Preventing Emergency Vehicle Crashes: Status and Challenges of Human Factors Issues. *Human factors* [Internet]. nov 2018 [cité 16 nov 2024];60(7). Disponible sur: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29965790/>
32. Brown LH, Whitney CL, Hunt RC, Addario M, Hogue T. Do warning lights and sirens reduce ambulance response times? *Prehosp Emerg Care*. 2000;4(1):70-4.
33. Rehn M, Davies G, Smith P, Lockey D. Emergency versus standard response: time efficacy of London’s Air Ambulance rapid response vehicle. *Emerg Med J* [Internet]. 1 déc 2017 [cité 4 févr 2024];34(12):806-9. Disponible sur: <https://emj.bmj.com/content/34/12/806>
34. Ho J, Lindquist M. Time saved with the use of emergency warning lights and siren while responding to requests for emergency medical aid in a rural environment. *Prehosp Emerg Care*. 2001;5(2):159-62.
35. Jarvis JL, Hamilton V, Taigman M, Brown LH. Using Red Lights and Sirens for Emergency Ambulance Response: How Often Are Potentially Life-Saving Interventions Performed? *Prehosp Emerg Care*. 2021;25(4):549-55.
36. Brown JB, Rosengart MR, Forsythe RM, Reynolds BR, Gestring ML, Hallinan WM, et al. Not all prehospital time is equal: Influence of scene time on mortality. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery* [Internet]. juill 2016 [cité 14 août 2024];81(1):93. Disponible sur: https://journals.lww.com/jtrauma/abstract/2016/07000/not_all_prehospital_time_is_equal__influence_of.15.aspx
37. Thézard F, McDonald N, Kriellaars D, Giesbrecht G, Weldon E, Pryce RT. Effects of Spinal Immobilization and Spinal Motion Restriction on Head-Neck Kinematics during Ambulance Transport. *Prehospital Emergency Care* [Internet]. 2 nov 2019 [cité 14 août 2024];23(6):811-9. Disponible sur: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10903127.2019.1584833>
38. Westerlund A, Vicente V, Hjelte Judell O, Lindström V. Preventing and alleviating patients’ symptoms of nausea and vomiting while in the care of the ambulance service - a qualitative study. *Int Emerg Nurs*. sept 2016;28:34-8.
39. J B, F S, M M, Ak E, J KR. Online Newspaper Reports on Ambulance Accidents in Austria, Germany, and Switzerland: Retrospective Cross-sectional Review. *JMIR public health and surveillance* [Internet]. 11 déc 2021 [cité 16 nov 2024];7(11). Disponible sur: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34766915/>
40. Sanddal TL, Sanddal ND, Ward N, Stanley L. Ambulance Crash Characteristics in the US Defined by the Popular Press: A Retrospective Analysis. *Emerg Med Int* [Internet]. 2010 [cité 4 févr 2024];2010:525979. Disponible sur: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3200082/>
41. Saunders G, Gough A. Emergency ambulances on the public highway linked with inconvenience and potential danger to road users. *Emerg Med J* [Internet]. mai 2003 [cité 4 févr 2024];20(3):277-80. Disponible sur: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1726091/>

ANNEXE 1

Résultats du questionnaire

Ancienneté dans la fonction d'ambulancier SMUR

	N 331	%
> 10 ans	158	47,7
< 5ans	100	30,2
Entre 5 et 10 ans	73	22,1

Statut dans la fonction

	N 331	%
Titulaire	285	86,1
Contractuel	35	10,6
Stagiaire	6	1,8
SMUR Privée	3	0,9
CDD	2	0,6

Êtes-vous titulaire de la Formation d'Adaptation à l'Emploi (FAE) d'ambulancier SMUR ?

	N 331	%
Oui, formation effectuée après la prise de poste	169	51,1
Oui, formation effectuée avant la prise de poste	99	29,9
Non, mais demande faite auprès de l'encadrement	47	14,2
Non	16	4,8

Avez-vous bénéficié d'une formation initiale à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence ?

	N 331	%
Oui, après la FAE	148	44,7
Oui, avant la FAE	135	40,8
Non, mais demande faite auprès de l'encadrement	27	8,2
Non	21	6,3

Dans quel centre avez-vous effectué votre formation ? (Plusieurs centres possibles)

	N 258	%
ACO Le Mans	203	78,7
Centaure	26	10,1
Beltoise Évolution	22	8,8
Autre	19	7,4

Quel était le volume horaire de cette formation initiale ?

	N 282	%
2 jours	238	84,4
1 jour	23	8,2
3 jours	12	4,2
Autre	9	3,2

Bénéficiez-vous d'une formation continue régulière ou d'autres niveaux de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence ?

	N 283	%
Non, mais demande faite auprès de l'encadrement	113	39,9
Non	77	27,2
Oui, tous les 2 à 3 ans	45	15,9
Oui, tous les 4 à 5 ans	40	14,1
Oui, tous les ans	8	2,8

Vous avez trouvé cette formation		
	N 283	%
Très utile	235	83
Utile	41	14,5
Peu utile	6	2,1
Sans intérêt	1	0,4
Sur quels types de vecteurs avez-vous réalisé votre formation ? (Plusieurs réponses possibles)		
	N 283	%
Véhicules légers	275	97,2
Ambulance de réanimation	155	54,8
Autre	17	6
Pensez-vous que cette formation a changé votre façon de conduire en intervention ?		
	N 283	%
Oui	248	87,6
Non	35	12,4
Pensez-vous que ce type de formation pourrait changer votre façon de conduire en intervention ?		
	N 48	%
Oui	47	97,9
Non	1	2,1
Quels éléments de formation vous semblent importants ? (Plusieurs réponses possibles)		
	N 331	%
Freinage d'urgence	297	89,7
Évitement	287	86,7
Perte d'adhérence	280	84,6
Dynamique du véhicule et transfert de masses	276	83,4
Conduite rapide	256	77,3
Temps de réaction et distances de freinage	247	74,6
Réglementation	192	58
Découverte des dispositifs d'aide à la conduite (ABS, ESP, ASR, AFU)	173	52,3
Conduite d'ambulance avec patient	165	49,8
Conduite préventive	163	49,2
Avez-vous déjà eu un accident de la circulation en intervention SMUR ?		
	N 331	%
Non	226	68,3
Oui, accident modéré, accrochage matériel	102	30,8
Oui, accident grave	3	0,9

ANNEXE 2

MODÈLE D'ATTESTATION DE SUIVI DU **MODULE 1** DE LA FORMATION A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET CONDUITE EN INTERVENTION D'URGENCE POUR LES AMBULANCIERS SMUR

Vu le code de la santé publique notamment les articles, L. 4393-1, D. 4393-1, R. 6123-1 à R. 6123-12 et R. 6123-14 à R. 6123-17 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'état de structure mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le référentiel en date du 20/01/2026 de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence pour les ambulanciers SMUR ;

Ambulancier/Ambulancière

Nom : _____ Nom d'usage : _____
Prénom : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Tél. : _____
Mail : _____

Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence

Raison sociale : _____
Coordonnées : _____

Date du stage : Du _____ au _____
Nom du responsable pédagogique : _____
Nom des formateurs intervenants : _____
Nom du responsable médical : _____

Je soussigné(e)

Directeur/directrice du Centre d'Enseignements de Soins d'Urgence, Mr/Mme

Atteste que,

Nom :

Nom d'usage :

Prénom :

Date de naissance :

Ambulancier(ière) diplômé(e) d'Etat

Domicilié(e) à :

- a suivi la formation **Module 1** prévue dans le référentiel de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence pour les ambulanciers SMUR ;
- est en capacité d'exercer au sein d'une structure mobile d'urgence et de réanimation.

Fait à

, le

Signature du responsable médical

Nota : Attestation valable pour une durée de 5 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation de quatorze heures dans un centre de formation agréé. La formation porte sur une actualisation des connaissances théoriques et un perfectionnement à la conduite, par le biais d'ateliers pratiques et de la conduite sur piste.

ANNEXE 3

MODÈLE D'ATTESTATION DE SUIVI DES **MODULES 2 ET 3** DE FORMATION A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET CONDUITE EN INTERVENTION D'URGENCE POUR LES AMBULANCIERS SMUR

Vu le code de la santé publique notamment les articles, L. 4393-1, D. 4393-1, R. 6123-1 à R. 6123-12 et R. 6123-14 à R. 6123-17 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'état de structure mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le référentiel en date du 20/01/2026 de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence pour les ambulanciers SMUR ;

Ambulancier/Ambulancière

Nom : Nom d'usage :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Mail :

Centre de formation agréé

Raison sociale :
N° de siret :
Coordonnées :

Date du stage : Du au
Nom du responsable pédagogique :
Nom des formateurs intervenants :

Je soussigné(e)

Directeur/directrice du centre de formation agréé, Mr / Mme

Atteste que,

Nom :

Nom d'usage :

Prénom :

Date de naissance :

Ambulancier(ière) diplômé(e) d'Etat

Domicilié(e) à :

- a suivi la formation **Modules 2 et 3** prévue dans le référentiel de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence pour les ambulanciers SMUR ;
- est en capacité d'exercer au sein d'une structure mobile d'urgence et de réanimation.

Fait à , le

Signature du responsable pédagogique

Nota : Attestation valable pour une durée de 5 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation de quatorze heures dans un centre de formation agréé. La formation porte sur une actualisation des connaissances théoriques et un perfectionnement à la conduite, par le biais d'ateliers pratiques et de la conduite sur piste.

ANNEXE 4

MODÈLE D'ATTESTATION DE SUIVI **D'ACTUALISATION DES CONNAISSANCES** DE FORMATION A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET CONDUITE EN INTERVENTION D'URGENCE POUR LES AMBULANCIERS SMUR

Vu le code de la santé publique notamment les articles, L. 4393-1, D. 4393-1, R. 6123-1 à R. 6123-12 et R. 6123-14 à R. 6123-17 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'état de structure mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le référentiel en date du 20/01/2026 de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence pour les ambulanciers SMUR ;

Ambulancier/Ambulancière

Nom : Nom d'usage :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Mail :

Centre de formation agréé

Raison sociale :
N° de siret :
Coordonnées :

Date du stage : Du au
Nom du responsable pédagogique :
Nom des formateurs intervenants :

Je soussigné(e)

Directeur/directrice du centre de formation agréé, Mr / Mme

Atteste que,

Nom :

Nom d'usage :

Prénom :

Date de naissance :

Ambulancier(ière) diplômé(e) d'Etat

Domicilié(e) à :

- a suivi la formation **d'actualisation des connaissances** prévue dans le référentiel de formation à la sécurité routière et conduite en intervention d'urgence pour les ambulanciers SMUR ;
- est en capacité d'exercer au sein d'une structure mobile d'urgence et de réanimation.

Fait à

, le

Signature du responsable pédagogique

Nota : Attestation valable pour une durée de 5 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation de quatorze heures dans un centre de formation agréé. La formation porte sur une actualisation des connaissances théoriques et un perfectionnement à la conduite, par le biais d'ateliers pratiques et de la conduite sur piste.